

מערך חילוץ והצלה

תפקידו של מערך החילוץ וההצלה לתת תמיכה לאזרחים באירועי חירום, באסונות ובאירועים רחבי היקף (ראו פרק 26). לשם כך נדרש שיתוף פעולה עם גורמים אזרחיים רבים אחרים. מערך החילוץ וההצלה בישראל מורכב מכמה גופים: מגן דוד אדום, שירותי כבאות והצלה (כב"ה), יחידות חילוץ מרחביות המאוישות במתנדבים, פיקוד העורף של צה"ל, משטרת ישראל ועוד גופים. פעולות החילוץ וההצלה הן מורכבות ודורשות מקצועיות ומגוון יכולות טכניות ומיומנויות תוך שיתוף פעולה מתמיד בין הגופים.

גורמי הרפואה עובדים על פי עקרון "שעת הזהב" (the Golden Hour; the Golden Time) כפי שמוזכר בספר ה-PHTLS (pre-hospital trauma life support). על פי עיקרון זה, יש למזער את הזמן הקריטי מרגע הקריאה לפינוי וחילוץ נפגעים ועד לרגע הגעתם ליחידת הטראומה בבית החולים, כדי להפחית את התמותה והתחלואה של הנפגעים. שעת הזהב כוללת את פרק הזמן מקבלת קריאת המצוקה, דרך ההזנקה, החילוץ, הטיפול, הפינוי לבית החולים ועד הכניסה לחדר הלב במחלקה לרפואה דחופה.

תרחישי החילוץ וההצלה הם מגוונים - תאונת דרכים, קריסת בניין, אירועי חומרים מסוכנים, שריפות, נפילה לתהום באזור שאינו נגיש ותרחיש ימי. דוגמאות אלו מדגישות את השונות בין האירועים השונים וכפועל יוצא גם את האמצעים, הכישורים והאתגרים שניצבים בפני המטפלים והמחלצים בכל אחד מהתרחישים. בפרק זה נתרכז בעקרונות הכלליים של חילוץ והצלה.

העקרונות הכלליים לחילוץ

שיתוף פעולה ותקשורת

הליך החילוץ וההצלה מורכב, ודורש לעיתים מיומנויות מיוחדות ושיתוף פעולה בין גורמי החילוץ וההצלה. עם זאת ייתכן שהצוות הרפואי ייקלע לאירוע שבו לא יהיו אנשי המקצוע המתאימים, ואנשי הצוות הרפואי יידרשו לתת את הטיפול המתאים תוך הפעלת שיקול דעת, יצירתיות ושמירה על בטיחות המטפלים ובטיחות המטופלים. יש לזכור בראש ובראשונה כי תפקיד המטפל הוא לטפל בנפגעים ולא להיות מופקד על מלאכת החילוץ. עוד חשוב להדגיש שאם יש אנשי מקצוע באזור, יש לתת לאנשי המקצוע בתחום זה, כגון לוחמי אש, יחידות חילוץ אזרחית או צה"לית, לעשות את עבודת החילוץ תוך שיתוף פעולה, יצירת תמונת מצב ותקשורת מתמדת בנושאים כגון: פרק הזמן שהחילוץ ימשך ואם יש צורך לעצור את פעולות החילוץ כדי להעניק טיפול דחוף, למשל: אינטובציה והנחת חוסם עורקים.

פשטות

עיקרון יסודי נוסף בהליך חילוץ והצלה הוא עקרון הפשטות. על החילוץ להיות מסודר ושיטתי: כדי לעשות זאת גורם מיומן צריך לתכנן מראש את החילוץ.

בטיחות

לפני שמתחילים חשוב להדגיש את עקרון הבטיחות - בטיחות המטפל ובטיחות הנפגע הם ראשונים במעלה

ונמצאים בבסיסן של כל ההחלטות והפעולות שמבצע הצוות הרפואי.

זיהוי הסכנות - השלב הראשון הוא זיהוי הסכנות. בכל שלב של החילוץ מההגעה למקום האירוע ועד להשלמת הפינוי המטפל צריך לשאול: "האם אני בטוח?" "האם הנפגע בטוח?"

בטיחות המטפל כוללת הערכת סיכונים והימנעות מפגיעה, תוך שימוש באמצעי מיגון: נעלים סגורות, אמצעי מיגון ייעודיים, למשל מגיני עיניים, כפפות עבודה, קסדה, שימוש במערכות נשימה ייעודיות.

שלבי החילוץ

מקובל לחלק את החילוץ ל-5 שלבים:

- 1) הערכת אופי האירוע ושליטה בסכנות
- 2) פילוס גישה אל הנפגע
- 3) הגשת טיפול רפואי ראשון לנפגע
- 4) שחרור וחילוץ את הנפגע
- 5) הכנת הנפגע לפינוי ופינוי הנפגע ממקום האירוע

במציאות חמשת השלבים האלה חופפים. לדוגמה, הערכת אופי האירוע ושליטה בסכנות הן פעולות שנמשכות לאורך כל תהליך החילוץ. אך למען התכנון של מבצע ההצלה, נוח לתכנן את המבצע לפי 5 שלבים אלו.

שלב 1: הערכת אופי האירוע ושליטה בסכנות

חילוץ והצלה מתחילים עוד לפני הגעת הצוות הרפואי אל מקום האירוע. התהליך מתחיל למעשה ברגע קבלת הקריאה ובדרך לאירוע. באופן אידיאלי תורן המוקד יתן פרטים מלאים על האירוע: אם למשל מדובר בתאונת דרכים - הוא יתן פרטים על מספר וסוג כלי הרכב המעורבים, מספר הנפגעים ומצבם, מצב התנועה והדרך אל מקום התאונה וממנה, פרטי כוחות ההצלה שכבר הגיעו למקום האירוע כדי שיהיה אפשר לתכנן את המהלכים.

פרטים לדוגמה:

- אם כבר הגיע למקום צוות ALS, צוות החובשים יידרש לבצע העמסה ופינוי בלבד בלי לפרוק את הנפגע מהניידת.
- אם הצוות מגיע כצוות ראשון לרכב שנפל לתהום ונדרש להכין ציוד נישא מהניידת והליכה אל מקום האירוע.

כאשר הצוות מגיע למקום יש לקיים הערכה ראשונית של אופי האירוע ולענות על 4 שאלות מרכזיות:

- 1) האם בטוח להתקרב אל הנפגע?
- 2) האם יש סכנה כלשהי לנפגע?
- 3) האם אני זקוק לעזרה כלשהי - ציוד או כוח אדם נוסף?
- 4) האם אני זקוק לציוד מיוחד כדי להגיע אל הנפגע?

שתי השאלות הראשונות בסקירת האירוע דורשות מן המטפל לקבוע אם יש סכנות מיידיות, ולפתור אותן אם ישנן.